

SONDA NASOGÁSTRICA

Rubén Pérez Fernández, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La sonda nasogástrica (SNG) es un tubo flexible, que puede ser de doble vía (Salem) o de una única luz (Levin), que se introduce hasta la cavidad gástrica desde los orificios nasales (o desde cavidad oral en situaciones especiales) para procedimientos de drenaje, descompresión o administración de fármacos.

INDICACIONES

Las principales indicaciones de la SNG son:

- Descompresión y drenaje gastrointestinal como tratamiento en la obstrucción intestinal.
- Administración de fármacos (pacientes con mecanismo deglutorio abolido o dificultado).
- Nutrición enteral.
- Lavado gástrico.
- Ayuda en la identificación de la hemorragia digestiva alta (ayuda a diferenciar sangrado del tracto digestivo alto frente al bajo).
- Profilaxis de broncoaspiración en pacientes con disminución del nivel de conciencia.
- Disminuye riesgo de aspiración, trata la distensión gástrica y permite aporte de medicación en pacientes intubados.

CONTRAINDICACIONES

- Estenosis rinofaríngea o esofágica.
- Sospecha o evidencia de perforación esofágica.
- Fracturas faciales o sospecha fractura base cráneo: sospecha de lesiones en la lámina cribiforme o medio faciales por el riesgo de localización intracraneal de la SNG.
- Ingesta de sustancias cáusticas: con riesgo de producir perforación gastrointestinal
- Cirugía gástrica o esofágica reciente (relativa).
- Varices esofágicas (relativa).
- Coagulopatía severa (relativa).

TÉCNICAS Y MATERIAL A UTILIZAR:

Dispondremos de sonda nasogástrica, guantes, bata desechable, mascarilla, lubricante, anestésico tópico (opcional), jeringa de 50cc adaptable a la sonda, bolsa de recogida o tapón, fonendoscopio, esparadrapo antialérgico de fijación.

Procedimiento

- Informar al paciente solicitando consentimiento y colaboración.
- Realizar lavado adecuado de manos y posteriormente utilizar medidas protección (riesgo epistaxis): bata, mascarilla y guantes desechables.
- Colocar posición Fowler (cabecero 45º-60º).
- Retirar prótesis dentales de existir.
- Estimación de la longitud de la sonda nasogástrica: medir desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y desde ahí a la apéndice xifoides, luego sumar 5 cm a la medida obtenida (en total aprox. 15 cm).

- Comprobar permeabilidad de narinas.
 - Aplicar anestésico tópico (opcional).
 - Lubricar extremo distal de la SNG.
 - Inserción a 90º respecto al macizo facial de forma paralela al cornete inferior pegando la SNG al suelo de la cavidad nasal.
 - Progresar la sonda delicadamente y pedir al paciente que trague de forma periódica para facilitar el paso de la SNG. La flexión cervical hacia adelante puede ayudar a la introducción adecuada hacia esófago.
 - Verificar colocación adecuada (ideal con control mediante radiografía de tórax). Métodos alternativos según contexto:
 - Aspiración espontánea de contenido gástrico ($\text{pH} < 4$). En caso de no salida de contenido de forma espontánea realizar aspirado con jeringa.
 - Insuflar 30-40cc de aire en la sonda mientras auscultamos borborismos audibles en epigastrio.
 - En paciente consciente mantener conversación adecuada sin desencadenar tos podría servir como indicador indirecto.
 - Fijación de la SNG con esparadrapo a la región perinaso-malar.
- **Bajo nivel de conciencia:** colocación bajo visualización directa con laringoscopio o pinzas McGill a través de cavidad oral. Como alternativa asistencia digital a través de cavidad oral con segundo y tercer dedos a nivel de orofarínge.
 - **Colocación orogástrica:**
 - Sospecha o confirmación de fractura base cráneo
 - Fracturas faciales
 - Utilización corto periodo de tiempo

COMPLICACIONES

Tasa 0.5%-1.5%.

- Epistaxis
- Náuseas y vómitos
- Sinusitis y otitis media.
- Rotura de varices esofágicas
- Intubación traqueobronquial
- Neumotórax
- Intubación intracraneal
- Perforación esofágica o faríngea
- Ruptura gástrica o duodenal
- Gastrotórax y gastrotórax a tensión
- Aspiración pulmonar

CONSEJOS

- Calentar manualmente la SNG facilita la intubación gástrica.
- En caso de atragantamiento o tos no retirar SNG más allá de orofaringe y reintentar (el paso de naso a orofaríngea es complicado y doloroso).
- Elevación mandibular desplaza la tráquea anteriormente liberando presión a nivel esofágico facilitando la maniobra de introducción.

BIBLIOGRAFÍA:

- Adams, J. and Jones, K. (2013). *Emergency medicine*. 2nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders, pp.382-389.e1.
- Castaño Palacios, A., Del Valle Cuadrado, O., Abellás Álvarez, C. and Poses Sobral, E. (2013). *Guía de actuación en urgencias*. 4th ed. p.632.
- Villaverde Laso, L. and Mudarra Reche, C. (2012). *Manual de diagnóstico y terapéutica médica*. 7th ed. Madrid: Universidad Complutense, Departamento de Medicina Interna, Hospital 12 de Octubre, pp.22-23**. **
- Hodin RA, Bordeianou L. Nasogastric and nasoenteric tubes. Ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. <http://www.uptodate.com> (Acceso 29 Mayo 2018).